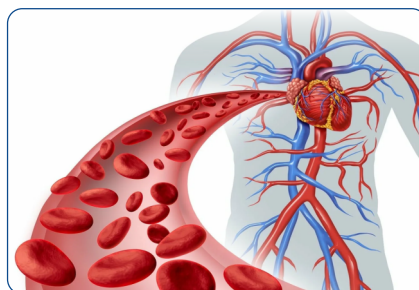


МЕТОВЕЛ®

Мелдония дигидрат – 500 мг 5 мл



- ИБС (стенокардия, миокард инфаркти) комплекс терапиясида;
- Сурункали юрак етишмовчилиги;
- Дишормонал кардиомиопатия;
- Мия қон таъминотининг ўткир ва сурункали бузилишлари (инсульт ва цереброваскуляр етишмовчилик) комплекс давосида;
- Тўр пардаси марказий венаси ва унинг шохлари тромбози;
- Меҳнат қобилиятининг пасайиши;
- Ақлий ва жисмоний зўриқиш (шу жумладан спортчиларда);
- Сурункали алкоголизмда абстиненция синдроми (специфик алкоголизм терапияси билан қўшиб).

ТИББИЙ ФОЙДАЛАНИШ БЎЙИЧА КЎРСАТМАЛАР

МЕТОВЕЛ (ME TOVEL) инъекция учун эритма



Таркиби:

1 ампула (5 мл) таркибида:
Фаол модда: мелдония дигидрат – 100 мг/мл
Ёрдамчи модда: инъекция учун сув

Тавсифи:

Шаффоф, рангсиз ёки бироз сарғиш рангли эритма.

Фармакологик хусусиятлари:

- Хужайраларни кислород билан таъминланишини яхшилади,
- Хужайраларни шикастланишдан ҳимоя қилади,
- Жисмоний ва ақлий иш қобилиятини оширади.

Қўллаш кўрсатмалари:

- Ишемик юрак касаллиги, миокард инфаркти, стенокардия.
- Сурункали юрак етишмовчилиги, кардиомиопатия.
- Мия қон айланишининг етишмовчилиги.
- Тўр пардаси марказий венаси тромбози, ретинопатиялар.
- Жисмоний ва ақлий зўриқиш.
- Сурункали алкоголизмда абстиненция синдроми.

Қўллаш усули ва дозалари:

- Юрак-қон томир касалликлари: 0,5–1 г/кун томир ичига (4–6 кун).
- Мия қон айланишининг ўткир бузилиши: 0,5 г/кун томир ичига 10 кун, сўнг таблетка шаклига ўтилади.
- Жисмоний ва ақлий зўриқиш: 0,5 г/кун томир ичига 10–14 кун.
- Алкоголизм: 0,5 г 2 марта/кун томир ичига 7–10 кун.

Қарши кўрсатмалар:

- Қон босимининг юқорилиги.
- Марказий асаб тизими органик шикастланиши.
- Ҳомиладорлик, эмизиш даври.
- 18 ёшгача бўлганлар.
- Индивидуал тоқат қилмаслик.

Ёмон таъсирлари:

Кам ҳолларда: тахикардия, артериал босим ўзгариши, ҳаяжон, аллергия реакциялар (тошма, шиш).

Махсус кўрсатмалар:

Жигар ва буйрак касалликларида эҳтиёткорлик билан қўллаш. Биринчи даражали юрак ишемиясида қўллаш мумкин эмас.

Дори воситалари билан ўзаро таъсири:

- Гипотензия чақирувчи дорилар, юрак гликозидлари таъсирини кучайтиради.
- Нитратлар ва кальций каналлари блокаторлари билан эҳтиёткорлик билан қўшиб ишлатилади.

Ортиқча дозалаш:

Ҳолатлар қайд этилмаган.
Препарат кам захарлидир.

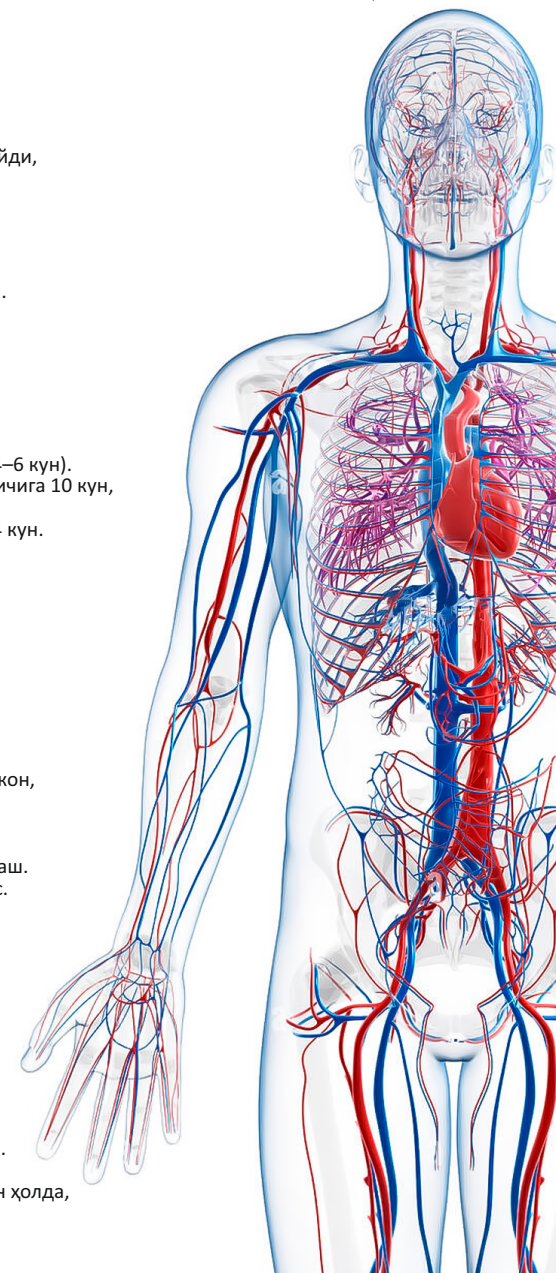
Чиқарилиш шакли: инъекция учун эритма 10% (5 мл ампулалар).

Сақлаш шароити: қоронғи жойда, ёруғликдан ҳимояланган ҳолда, 25°C дан юқори бўлмаган ҳароратда.

Яроқлилик мuddати: 2 йил.Рецепт бўйича берилади.

Маълумотлар мутахассислар учун мўлжалланган.

Махсусотлар сифати бўйича даъво (таклиф)ларни қабул қилувчи ташкилотнинг номи ва манзили
Республика Ўзбекистон ИП МЧЖ «WELL MED PHARM» Республика Ўзбекистон, 100057, Тошкент ш., Олмазор тумани,
2-пр. Чуқурсой кўч., 96А уй. Тел: +998781202545 Факс: +998712281695 e-mail: wellmed.inf@gmail.com



Метовел таъсир қилиш механизми

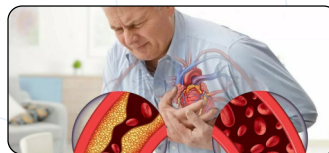
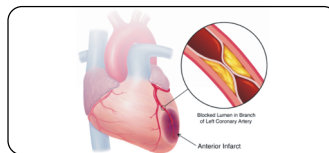


ГББ - gamma-бутиробетаин; ОПСС - умумий периферик қон томир қаршилиги; СЖК - эркин ёғ кислотаси.

КАРДИОЛОГИЯ: ИБС, стенокардия, ХСН →
↓ ангиаль хуружларининг частотаси,
↑ жисмоний машқлар толерантлиги.

НЕВРОЛОГИЯ: ЦВЗ,
инсультдан кейинги ҳолат →
↑ мия перфузияси,
тикланишни тезлаштириш.

КОМОРБИД БЕМОРЛАР (ИБС + АГ):
қон томир асоратларини олдини олиш
(инсульт, юрак хуружи).



Метовел таъсир қилиш механизми

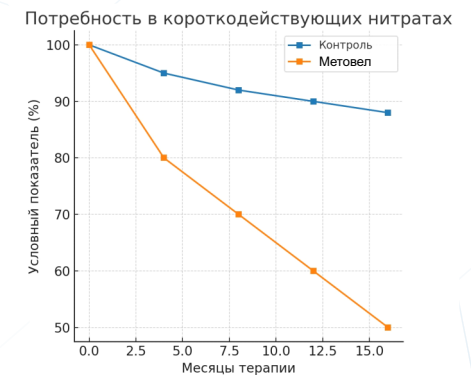
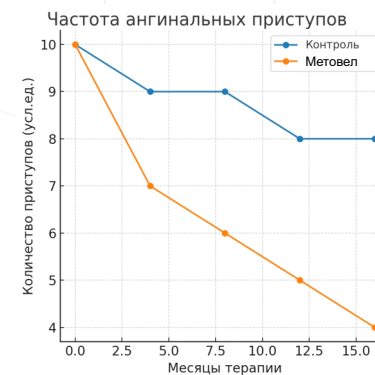
NO - боғлиқ бўлган механизм:

P-FOX механизми:



СВОП - электрон ташиш занжири ва у билан боғлиқ фосфорланиши тизими
СК - стенокардия

Қандли диабет + ХСН + ИБС бўлган беморларда



- СК ҳужумларини частотасини камайтиради
- Нитратларга бўлган эҳтиёжни камайтиради
- ХСН симптомларини енгиллаштиради
- Систолик ва диастолик функцияни яхшилайди.

Кўрсаткичлар	Гуруҳ Метовел	Назорат гуруҳ
Гликатланган Гемоглобин (ХбА1с)	-12%	-3%
Триглицеридлар (ТГ)	-26,9%	-7,7%
Паст зичликдаги липопротеинлар (ЛПНП)	-27,1%	-8,3%

1. Михин В., Хлебодаров Ф. Перспективы применения милдроната у больных с сердечно-сосудистой патологией. Российский кард. журн. 2010;4(84):58-68.
2. Dzerve V, Matsone D., Pozdnyakov Y., Oganov R. Mildronate improves the exercise tolerance in patients with stable angina. Seminars in Cardiovascular medicine. 2010;16:3.